

Información Paciente

Nombre : Alejandro Patricio Cariqueo Monrroy
Edad : 55a 8m 18d
Dirección : La Armonica 1259 V El Almendral

Rut : 10.636.062-6
Fecha Nacto: 12/04/1967
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2009628
Sexo : Masculino
Teléfono : 923725069

N° Epicrisis
317569

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 21/07/2022 23:44

Días Estadía: 162

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Bási

Fecha Egreso : 30/12/2022 11:12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Diabetes Mellitus 2 Insulino requirente; Hipertensión Arterial;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Mutilación Grave Mano, Aseo. Quir. Completo C/S Osteosíntesis, C/S Injertos - 23/07/2022 05:35 - Raul Barraza Adones
Amputación Pierna - 30/07/2022 19:45 - Cristian Marin Oviedo
Amputación Pierna - 01/08/2022 23:00 - Carlos Morales Mora

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN DE TRASLADO 19/12/22
NOMBRE: Alejandro Cariqueo Monrroy
RUT: 10636062-6
EDAD: 55 años
FI SU CASR: 21/07/22
FI UPC: 22/07/22
FI UTIM: 25/08/22
FI Sala: 02/09/22
FI HC: 12/09/22

ANTECEDENTES

Médicos: Diabetes Mellitus 2 IR (daño de órgano blanco con pie de Charcot bilateral), HTA

Quirúrgicos: Hospitalización en Mayo-Junio 2020

- 20/06/20 aseo artritis séptica de rodilla derecha
- 21/06/20 aseo artritis séptica de muñeca izquierda
- 27/06/20 aseo artritis séptica de rodilla derecha
- 05/07/20 aseo pie y drenaje de colecciones en tobillo
- 09/07/20 aseo pie y tobillo + amputación 2° orjejo
- 21/07/20 aseo pie derecho

Fármacos: Se desconoce.

Hábitos TBQ (+) suspendido hace 14 años, OH+ 7 L cerveza al día, habría suspendido hábito 2018-2019, Drogas (-)

Alergias: niega.

Sociales: Vive solo. Hijo menciona independencia en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, sin alteraciones cognitivas.

ANAMNESIS PRÓXIMA

Dos semanas de evolución de aumento de volumen en ambos tobillos asociado a lesiones con secreción purulenta en relación

Fecha Epicrisis : 30/12/2022 11:09

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 30-12-2022 11:09:55

Página 2 de 6

a ambos maléolos laterales (se desconoce presencia de úlcera venosa/arterial previa), postración progresiva, compromiso de conciencia cuali-cuantitativo y fiebre. Ingres a al SU grave, traído por SAMU. Se describe taquicárdico 122 lpm, PA 114/77 mmHg, afebril, taquipneico hasta 48 rpm Sat 94% ambiental, HGT 542 mg/dL. Con abundante secreción purulenta exteriorizándose de heridas de ambos maléolos. En exámenes con hiperglicemia en 611, osmolaridad 310, ph 7.32, BIC 15.8, CO2 30, BE - 10, Láctico 62, Crea 1.5, BUN 50, K 5.8 (en contexto de hemólisis), Na 129 (corregido 137), GB 14980, PCR 522. En SU con deterioro progresivo, requerimientos de reanimación con cristaloides e inicio de DVA. En este contexto se realiza secuencia de intubación rápida y conexión a VMI con ventilación protectora. Posterior traslado a UCI para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UPC

- 1.Shock séptico severo
Artritis séptica bimalleolar, colección en tercio distal de pierna izquierda
Neumonía bilateral obs. embolias sépticas
Infección del tracto urinario
- 2.Cetoacidosis diabética
- 3.Injuria renal aguda
- 4.Antecedentes: DM2 IR, HTA, pie de Charcot bilateral.

Microbiología:

22/07: UC y HC (+) SAMR
CAET: Serratia Marcescens

AngioTAC TAP + EEII (22/07/22): AngioTAC de extremidades inferiores, sin hallazgos de significado patológico. Signos de una ectopia renal cruzada fusionada a derecha. Colección con signos de organización y burbujas de gas en su interior en las partes blandas anteriores y laterales del tercio distal de la pierna izquierda, de etiología inflamatoria-infecciosa. Opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales condensantes, probablemente determinada por una neumopatía de etiología inflamatoria-Infecciosa con componente atelectásico múltiple. Múltiples nódulos pulmonares bilaterales. Colelitiasis.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS:

1.Hemodinamia: Ingres a cursando shock séptico, con requerimientos altos de NAD de forma prolongada. Evolución favorable con volemicación y control de focos de sepsis, suspendiendo vasoactivos. Posteriormente sin conflicto, con PA que tiende a límite bajo, sin requerimiento de hipotensores.

2.Ventilatorio: En UEA se conecta a VMI por shock séptico profundo y compromiso de conciencia, con requerimientos transitorios de FiO2, por lo que se realizó AngioTAC el 26/07 encontrando TEP. VMI prolongada, se extuba el 23/08 sin incidentes. Actualmente FiO2 ambiental. Anticoagular por 6 meses.

3.Infeccioso: ingresa el 22/7 clínicamente con aumento de volumen en ambos tobillos, al TAC TAP y de extremidades con: signos de artritis séptica y colección en tobillo izquierdo, neumonía cavitada bilateral (interpretado como embolias sépticas) y nefritis derecha. Se toman cultivos el 22/7, positivos para SAMR en sangre (HCT 1 y 2), en cultivo de herida del pie y en urocultivo.

El 23/7 se realizó aseo quirúrgico, rescatando cultivo de colección, cultivo tejido pierna izq, cultivo tejido articulación tibia: todos (+) SAMR. Inicialmente cubierto con Ceftriaxona+Clindamicina, se ajustó esquema a Vancomicina tras resultado de cultivo.

Se complementó estudio con RM de ambos pies que informa importante compromiso óseo, desestimando posibilidad quirúrgica con fines funcionales, decidiendo amputación infracondílea bilateral, realizadas el 30/07 y 01/08.

Por HCTs de control intratratamiento persistentemente (+) se cambió terapia a Linezolid (31/07). Hemocultivos negativos para SAMR desde el 31/7.

Ecoscopías con imagen hiperecogénica dependiente de cuerda tendínea en válvula mitral, sospechosa de vegetación (vs músculo papilar hipertrófico), con sospecha de endocarditis. Evaluado por cardiología, se estudió con EcoTE (01/09) , sin hallazgo de vegetaciones intracavitarias. Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica global y segmentaria conservada (Fracción de Eyección 55%).

- . Aurícula izquierda levemente dilatada, sin trombos en su interior.
- . Orejuela izquierda normocontráctil, sin trombos
- . Alteraciones degenerativas de válvulas mitral y aórtica con insuficiencias leves.
- . Cavidades derechas normales.
- . Presión sistólica de arteria normal en rango normal.

Fecha Epicrisis : 30/12/2022 11:09

Página 2 de 6

Fecha Última Actualización: 30-12-2022 11:09:55

Página 3 de 6

- . Foramen oval permeable pequeño.
- () Estudio sin imágenes sugerentes de endocarditis.

Se solicita cintigrama óseo para evaluar resolución de focos infecciosos:

Cintigrama óseo 14/09: Aumento de perfusión, vascularización y actividad osteoblástica en el aspecto superior del acetábulo derecho y en el trocánter mayor del fémur ipsilateral, sugerente de corresponder a focos de osteomielitis. Signos de sinovitis de la rodilla derecha, de probable origen infeccioso dado los antecedentes clínicos. Foco de actividad osteoblástica anormal en el aspecto lateral derecho del cuerpo vertebral de T8, sospechoso de corresponder a espondilodiscitis. De estimarse clínicamente necesario se sugiere complementar con RM para mejor caracterización. Focos de leve mayor captación en la 9ª y 11ª costillas izquierdas de probable origen postraumático antiguo. Cambios de aspecto inflamatorio/degenerativo en el resto de las localizaciones descritas.

Con resultado anterior, infectología indica mantener linezolid y se realiza estudio dirigido de focos con RM:

- RM cadera (28/09): Signos de artropatía coxofemoral derecha con edema óseo, erosiones y sinovitis, considerar como primera posibilidad una artritis séptica con signos de osteomielitis. Miositis de músculos iliopsoas, aductores y glúteos a derecha con colección con caracteres un absceso en glúteo medio que ha disminuido de tamaño respecto a estudio previo.
- RM rodilla (06/10): artropatía inflamatoria tricompartmental de la rodilla con fracturas en el compartimento externo con acentuado edema óseo. No hay evidencias categóricas de osteomielitis ni artritis séptica. Maceración degenerativa de los meniscos.
- RM cerebro y columna (06/10): Hallazgos compatibles con embolias sépticas encefálicas, espondilodiscitis T7-T8, L4-L5 y L5-S1 artritis séptica facetaria L5-S1 izquierda dado el antecedente de referencia. Sinovitis facetaria lumbar multisegmentaria. Leves cambios degenerativos multisegmentarios de columna.

Respuesta de interconsultas:

- TMT cadera: sin dolor a la palpación de ambas caderas, sin dolor a la palpación trocantérica, sacra o de musculatura glútea, sin cambios en ROM post AP supracondílea. Sin necesidad de abordaje quirúrgico actual. Control al alta con equipo de cadera en Poli CDT Traumatología pasillo 4 del alta.
- TMT columna: espondilodiscitis sin requerimientos actuales de cirugía, con germen identificado, mantener ATB.
- TMT rodilla: ROM limitado 70-100°, sin derrame articular, sin aumento de T° local. Al alta control con equipo rodilla.
- Reevaluación infectología: hemocultivos de control negativos hace 3 meses (sin aislamientos de SAMR, nuevos), parámetros inflamatorios bajos. Indican pasar a cotrimoxazol forte y seguimiento de perfil hematológico, VHS, PCR, BUN/creat/ELP y suspender line zolid.

Se solicita RM de control de cerebro, columna total y rodilla el 21/12, informa: Disminución del edema vasogénico y desaparición del refuerzo de las embolias sépticas encefálicas de ambos hemisferios cerebrales. Sin nuevas lesiones encefálicas. Espondilodiscitis T7-T8, L4-L5 y L5-S1, artritis séptica facetaria L5-S1 izquierda sin variaciones significativas.

Con lo anterior, infectología indica mantener Cotrimoxazol a permanencia y control ambulatorio al alta.

En suma, paciente con infección diseminada por MRSA, poliartritis séptica, absceso glúteo de foco primario probable cutáneo/partes blandas, embolías sépticas cerebrales, pulmonares y renales. Recibió cobertura con Vancomicina, luego Linezolid desde el 31/07 (HC negativos para SAMR desde el 01/08) luego Cotrimoxazol forte desde 04/11. Resolución de lesiones cerebrales con estabilidad de focos de OM en columna, se indica ATB a permanencia.

Microbiología:

22/7: HCT 1 y 2, cultivo herida pie y UC: (+) SAMR.

23/7: Cultivo colección, cultivo tejido pierna izq, cultivo tejido articulación tibia: (+) SAMR. /CAET (+) SAMR y Serratia marcescens.

28/7: HCT 1 y 2 (+) SAMR /CAET (+) Serratia /UC(-)

31/7: HCT 1 y 2 (-)

01/8: HCT 1 y 2 (-); Cultivo punta catéter (+) S. epidermidis MR

04/8: HCT 1 y 2 (-)

05/8: CAET (+) serratia

09/8: HCT 1 y 2; cultivo punta catéter y CAET (+) Serratia marcescens

UC(+) E. coli

15/8: HCT 1 y 2 (-); UC(-)

17/8: CAET (+) Serratia y P. aeruginosa resistente a carbapenémicos

29/8: UC(-)

Fecha Epicrisis : 30/12/2022 11:09

Página 3 de 6

Fecha Última Actualización: 30-12-2022 11:09:55

Página 4 de 6

30/8: Colección glúteo derecho 1 y 2 (+) SAMR
13/10: UC(+) e. coli
15/10: UC(-)

Intercurrencias resueltas:

- 28/07 Traqueobronquitis por MRSA y Serratia, se agregó Imipenem 7 días completando tratamiento.
- 09/08 NAVM bacteriémica por Serratia, también presente en CVC, e ITU por E. coli (R) a Ciprofloxacino. Por registros, recibió Amikacina 3 días, además Imipenem desde el 09/08 (16 días de tratamiento total).
- 16/08 NAVM por PSAE (R Imipenem) y S. marcescens, a cobertura ya descrita se agregó Ciprofloxacino.
- 17/08 Absceso glúteo foco primario hallazgo en TAC de control, se realiza drenaje el 29/08. Sin nuevo aumento de volumen (en paralelo tto con linezolid).
- Traqueobronquitis por PSAE resistente a carbapenémicos tratada con ciprofloxacino.
- Síndrome diarreico agudo con CD y antígeno (-) autolimitado.
- ITU con UC (+)E coli R a Tazonam, tratada con amikacina.
- Rash máculo papular pruriginoso, evaluado por Dermatología con dg de micosis, tratado con Ketoconazol tópico, resuelto.

4.Tromboembólico: En contexto de requerimiento transitorio de O2 se realizó nuevo AngioTAC (26/7), con hallazgo de TEP. A la ecoscopia se describe sin signos de sobrecarga derecha. Se inicia anticoagulación con enoxaparina, que se mantiene por 6 meses. Completa tto.

5.Medio interno: Cursa con AKI hasta Crea 3.8 y BUN 90, requiriendo 1sesión de TRR, en contexto de probable NTA, evoluciona con poliuria e hipernatremia, ya resuelto.

Hipokalemia moderada persistente, requirió cargas IV de KCl+MgSO4. Sin hipertensión asociada, sin sospecha de shift. Estudio con FeK impresiona pérdidas extrarrenales de potasio. Se indica aporte de KCl oral, normalizando niveles, por lo que se suspende. Desde entonces se mantiene K en rango, sin suplementación. Seguimiento ELP.

6.Metabólico: Al ingreso cursa con CAD, resuelta precozmente. Se inicia esquema basal-correccional y se agrega metformina (ya con función renal normal), logrando buen control metabólico.

7.Quirúrgico: Muñones de amputación se observan sanos. Destaca aumento de volumen rodilla derecha, doloroso sin signos inflamatorios. Con TAC del 17/08 que se observa derrame articular. Evaluado por traumatología, no les impresiona artritis séptica. Se solicita puncionar por radiología intervencional, refieren sin líquido susceptible de punción. Evoluciona con disminución de volumen de rodilla, con RM (06/10) que muestra artropatía inflamatoria tricompartmental + fracturas en el compartimento externo con acentuado edema óseo. Sin evidencias cate góricas de osteomielitis ni artritis séptica Maceración degenerativa de los meniscos. Sin necesidad de intervención según TMT rodilla. Se maneja con analgesia y KNT, en mejoría.

8.Rehabilitación:

- FNA: con disfonía post intubación, se realiza terapia de fonación y seguimiento por fonoaudiología. Con disfagia que mejora con terapia, actualmente sin restricción en consistencia.
- Motor: cursa polineuropatía del paciente crítico. Con mayor dolor en rodilla derecha, sin derrame puncionable según radiología. Inicialmente dolor de difícil manejo. Seguimiento por fisiatría, que ajusta analgesia, inicialmente con buprenorfina + metadona horario + pregabalina + paracetamol. Actualmente analgesia en decalaje, suspende opioides. Con rehabilitación pre protésica con KNT full, logra importante avance, logrando control de tronco y mejoría de ROM. Actualmente trabajando en transferencias. Se hace entrega de silla de ruedas por asistente social.

9.Salud Mental: Paciente lábil emocionalmente, refiere ánimo bajo. Se envía IC a Psiquiatría de enlace. Evaluado por especialidad, sin indicación actual de psicofármacos. En seguimiento por psicología. Durante el seguimiento eutímico, motivado en rehabilitación, aunque ansiedad en relación a volver a caminar.

8.Social: separado. Vivía solo, arrendaba depto en 3er piso, desde 2020 sin trabajo formal principalmente por estado de salud; se había mantenido económicamente con subvenciones del estado. Actualmente recibe pensión de invalidez que ha retirado su hijo.

Diagnósticos actuales:

Activos:

Fecha Epicrisis : 30/12/2022 11:09

Página 4 de 6

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 30-12-2022 11:09:55

Página 5 de 6

- 1) Infección diseminada por SAMR
 - 1.1) Embolías sépticas cerebrales (RM /10/22)
 - Linezolid desde 31/07 al 03/10
 - Cotrimoxazol forte desde 04/11 hasta la actualidad
- 2) TEP mutisegmentario (26/7) en anticoagulación con enoxaparina

Resueltos:

- 1) Shock séptico, resuelto
 - 1.1 Infección diseminada por SAMR -- en tto
 - 1.1.1 Artritis séptica de tobillos bilateral
 - 1.1.1.a) Aseo Qx 23/07
 - 1.1.1.b) Amputación infracondílea bilateral 30/07 y 01/08
 - 1.1.2 PNA resuelta
 - 1.1.3 Neumonía bilateral obs embolías sépticas
 - 1.2.VMI 22/07- 23/08
- 2) NAVM bacteriémica por Serratia tratada
- 3) NAVM por PSAE tratada
- 4) AKI prerrenal resuelta
 - 4.1 TRR 1 sesión
 - 4.2 NTA resuelta
- 5) Hipokalemia moderada Obs pérdida extrarrenal
- 6) ITU baja (+) E coli BLEE
- 7) Intercurrencias descritas

En resumen, paciente con amputación infracondílea bilateral secundaria a osteomielitis, con múltiples intercurrentias infecciosas, que ha presentado evolución favorable, estable en lo clínico. Lo principal es que requiere aún apoyo intensivo en rehabilitación, para poder optar a prótesis de ambas piernas, por lo que se estima que la mejor opción es realizarlo hospitalizado. Se postula a HSJM para rehabilitación motora full.

Diagnóstico de Egreso

Sepsis Debida A Staphylococcus Aureus -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, HDN estable, afebril, buena tolerancia oral.

Plan Post Alta

Régimen bajo en sal, diabético (máximo 200 grs de carbohidratos al día).
Mantener actividad física a diario.

Medicamentos:

Insulina NPH 16 U AM 4 U PM
Cotrimoxazol FORTE, 1 comp c/12 hrs VO (FI: 04/11)
Metformina 850 mg, 1 comp al desayuno y 1 al amuerzo VO
Ácido fólico 5 mg al día VO
Omeprazol 40 mg día VO
Paracetamol 1 g cada 8 h VO
Pregabalina 75 mg c/12 hrs
Tramadol/paracetamol 37.5/325 1 comprimido SOS si dolor
PEG 15 g en 200 cc de agua c/8 hrs VO

Controles en ambulatorio en CDT hospital:

- Medicina física y rehabilitación: evaluación pre protésica
- Infectología, en 1 mes, con exámenes y resultado de RM ro de control.

- Control de diabetes y retiro de insulina en su CESFAM correspondiente.

Fecha Epicrisis : 30/12/2022 11:09

Página 5 de 6

- Ingresar
Por uso de Metformina suplementar con B12 cada 6 meses

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Matías Tapia Paschke

Becado/Residente



Rene Aedo Benavente

Médico Tratante (Staff)